

CONSULTORIO PSICOLÓGICO	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD PROTOCOLO DE CIERRE Y ALTA CLÍNICA	Código: PRD-CL-04 Versión: 01 Fecha: Agosto 2026
------------------------------------	--	---

PROTOCOLO DE CIERRE Y ALTA CLÍNICA

1. OBJETIVO

Definir los criterios clínicos y administrativos, así como el protocolo metodológico, para la culminación formal del proceso psicoterapéutico, garantizando un cierre ético, la prevención de recaídas y el resguardo definitivo del expediente clínico.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación del cumplimiento de objetivos terapéuticos (o causales de terminación anticipada) y termina con el cierre formal del expediente clínico activo pasándolo al archivo inactivo.

3. RESPONSABLES

- Profesional en Psicología Tratante.

4. MARCO NORMATIVO

- Ley 1090 de 2006 (Finalización de la intervención clínica).
- Resoluciones de gestión documental y archivo de Historias Clínicas.

5. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

- 5.1. Identificación de Criterios de Alta o Terminación: Determinar la viabilidad del alta basado en alguna de estas causales: a) Cumplimiento de metas terapéuticas. b) Remisión a otro nivel de complejidad por desborde del alcance. c) Deserción o abandono injustificado de las sesiones por parte del paciente. d) Imposibilidad técnica o conflicto de intereses del profesional.
- 5.2. Sesión Formal de Cierre (Alta Exitosa): Cuando aplique, dedicar la última sesión a evaluar conjuntamente los logros alcanzados, consolidar las herramientas de afrontamiento adquiridas y establecer un plan preventivo de recaídas a corto y mediano plazo.
- 5.3. Elaboración de Epicrisis o Resumen Clínico: Redactar un resumen estructurado que contenga: motivo de consulta inicial, impresión clínica, resumen del tratamiento

CONSULTORIO PSICOLÓGICO	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD PROTOCOLO DE CIERRE Y ALTA CLÍNICA	Código: PRD-CL-04 Versión: 01 Fecha: Agosto 2026
------------------------------------	--	---

realizado, evolución y estado general al momento del alta. **IMPORTANTE:** Este documento solo se entregará al paciente bajo solicitud formal y expresa.

- 5.4. Cierre Administrativo en Historia Clínica: Registrar en el expediente la nota final de evolución especificando de manera clara y directa el motivo del cierre del caso (Alta terapéutica, Abandono, Remisión externa).
- 5.5. Gestión Documental: Transferir el expediente al archivo de retención documental (archivo central) asegurando su custodia por el tiempo estipulado en la ley colombiana (mínimo 15 años totales desde la última atención).

6. PUNTOS DE CONTROL PARA AUDITORÍA

- Existencia de una nota de evolución explícita que argumente y justifique clínicamente el cierre del caso.
- Registro de trazabilidad de entrega de epicrisis, firmado por el paciente al recibirlo (si lo solicitó).
- Cierre formal y bloqueo del folio en el sistema para evitar modificaciones póstumas no autorizadas.